Časová naléhavost: RUTINA *Objednal:*Centrální operační sál

Laboratorní vyšetření

Ze dne:

Pacient 2

Dat. nar.: *Č. poj.:*

Bydliště: *Kód poj.:*

Histologie

B_AA Lokalizace 1 Text...

B_AA Lokalizace 1

PRŮVODNÍ LIST K ZÁSILCE BIOPTICKÉHO MATERIÁLU

Vyšetřovací číslo:
Datum odběru: Datum příjmu: Datum odeslání:
Žadatel vyšetření:
Klinická diagnóza:C165
TOPOGRAFIE ODBĚRU: subtotální resekát žaludku s tumorem antra
KLIN. DIAG.:
Pacient s karcinomem angulární řasy malé kříviny žaludku. Již 4 cyklech neoadjuvantní chemoterapie FLOT do 2026. Indikován k totální gastrektomii, D2 lymfadenektomii a rekonstrukci Roux en Y.

DIAGNÓZA: C165
CHIRURGICKÉ VYŠ.:
Subtotální resekce žaludku, rekonstrukce Roux en Y, D2 lymfadenektomie, laváž, drenáž

NÁLEZ:
1/3
Makropopis:
V nádobce označené "žaludek" zaslán resekát části žaludku s přilehlou tukovou tkání a omentem, resekát celkové velikosti 35 x 33 x 4 cm. Z čehož část žaludku velikosti 16 x 7 x 4,5 cm. Po rozstřižení sliznice přiměřeně zřasená, přecházející v oblast, která je nápadně překrvená, se suspektním tumorózním ložiskem velikosti 2,8 x 2,5 x 0,3 cm, ložisko s navalitějšími okraji, dále i s patrnou ulcerací, která je velikosti 1 x 1 cm, spodina béžové barvy. Suspektní tumorózní ložisko je od aborální resekční plochy, kterou barvím modře, vzdáleno 1,5 cm, od orální resekční plochy, kterou barvím černě, je ložisko vzdáleno 4,7 cm. Stěna žaludku kliniky porušena, perforace velikosti 4 x 3 cm, bez patrné vitální reakce. Omentum velikosti 36 x 30 x 2 cm, na řezu zastižena pouze tukově vazivová tkáň, bez ložiskových změn.
mb

mikropopis:
a-v/ V extenzivně zpracovaném materiálu jsou v místě popsiovaného tumoru zastižena četné hlenová jezírka (A/PAS +) s nehojnými reaziduálními CKAE1/3 pozitivními nádorovými buňkami, jejichž proliferační aktivita v Ki67 dosahuje 10 %. HP je negativní (IHC). RP jsou intaktní.

Závěr:
1. histologický typ nádoru: adenokarcinom
2. velikost tumoru: 28 x 25 x 3 mm
3. stupeň diferenciace nádoru (grading): X
4. angioinvaze - ne
5. perineurální šíření - ne
6. hloubka invaze (šíření nádoru): do muscularis propria
7. resekční okraje: intaktní
8. počet a stav mízních uzlin: vyšetřeno 14 uzlin, bez maligních struktur

9. přítomnost lymfovaskulární invaze (LVI): ne
10. pTNM: ypT2 ypN0
woz

Dodatek nálezu 2026
Imunohistochemické vyšetření:
Claudin18/CLDN18 (Ventana, klon 43-14A, RxDx Assay).....TC 25 %
Hodnocení: NEGATIVNÍ
Aktuální platná hranice pozitivity CLDN18 je rovno nebo více než 75 % TC (střední nebo silná membránová pozitivita nádorových buněk, 2+/3+).

Her2neu (Ventana, klon 4B5).....0 (negativní)

PDL1 klon 22C3 DAKO..... negativní: méně něž 1 (CPS = 0,5)
Aktuálně platná hranice pozitivity pro karcinom žaludku a gastroezofageální junkce : více či rovno 1

M1:	M81403	ADENOKARCINOM	G:	P:1
M2:			G:	P:
M3:			G:	P:
TOP:	T63	ZALUDEK		